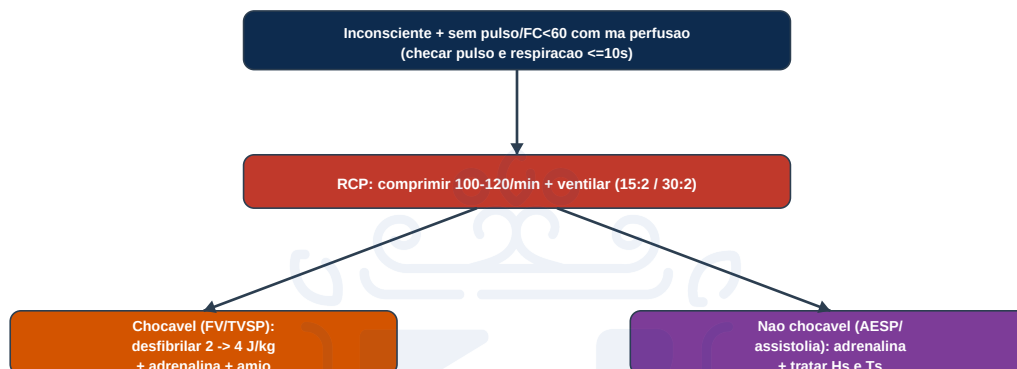


PCR NA INFÂNCIA — PALS

FLUXOGRAMA — PALS (C-A-B)

PCR PEDIÁTRICA — RCP DE ALTA QUALIDADE



CONTEXTO — DIFERENTE DO ADULTO

A PCR PEDIÁTRICA É HIPÓXICA

- ~80% das PCRs em crianças são secundárias a HIPÓXIA e CHOQUE (não cardíaca primária)
- Causas: respiratórias (obstrução de VA, pneumonia, SDRA, depressão do SNC) e circulatórias (desidratação, sepse, anafilaxia, cardiogênico)
- Cardíaca primária é minoria (cardiopatias congênitas, canalopatias/QT longo, TV)
- Por isso, prevenir = reconhecer e tratar precocemente a insuficiência respiratória e o choque
- Diagnóstico clínico: inconsciência + apneia/gasping + ausência de pulso central

RECONHECIMENTO E RCP

Rx C — COMPRESSÕES DE ALTA QUALIDADE

Pulso em ≤ 10 s: lactente (<1 a) BRAQUIAL; criança (>1 a) carotídeo/femoral. Iniciar RCP se sem pulso OU FC < 60 com má perfusão

Frequência 100-120/min; profundidade $\sim 1/3$ do diâmetro AP (lactente ~ 4 cm, criança ~ 5 cm); retorno total do tórax; minimizar interrupções

Técnica: lactente = 2 polegares (2 socorristas) ou 2 dedos (1 socorrista); criança = 1 ou 2 mãos (região hipotenar)

Relação compressão:ventilação = 15:2 (2 socorristas) | 30:2 (1 socorrista)

Via aérea avançada: compressões contínuas + 1 ventilação a cada 2-3s (20-30/min); BVM com O₂ 100%, 1s/ventilação com elevação do tórax

DESFIBRILAÇÃO E DROGAS

Item	Dose / detalhe
Desfibrilação (FV/TVSP)	1o choque 2 J/kg; subsequentes 4 J/kg (até 10 J/kg ou dose adulto). Ritmos chocáveis são raros (<10%)
ADRENALINA (todos os ritmos)	0,01 mg/kg (0,1 mL/kg da solução 1:10.000) IV/IO, a cada 3-5 min
Amiodarona (FV/TVSP refratária)	5 mg/kg IV/IO em bolus, repetir até 2x
Lidocaína (alternativa)	1 mg/kg IV/IO
Bicarbonato (restrito)	Só em PCR prolongada com acidose grave, hipercalemia ou intoxicação por ADT

CAUSAS REVERSÍVEIS — Hs e Ts

PROCURAR E TRATAR

- Hipovolemia: cristalóide 20 mL/kg IV/IO em bolus rápido (repetir conforme necessário)
- Hipóxia: via aérea avançada + O₂ 100% (a causa mais comum na criança)
- H+ (acidose): bicarbonato 1 mEq/kg IV se acidose grave documentada
- Hipercalemia: gluconato de cálcio 10% 0,5-1 mL/kg (máx 20 mL) + solução polarizante
- Hipotermia (reaquecer); Hipoglicemia (corrigir)
- Ts: pneumotórax hipertensivo (toracocentese 2o EIC), tamponamento, toxinas, TEP

CUIDADOS PÓS-RCE

Rx ESTABILIZAR E NEUROPROTEGER

Respiratório: otimizar ventilação/oxigenação (SatO₂ 94-99%; evitar hiperóxia)

Hemodinâmico: manter PA adequada com fluidos e drogas vasoativas

Temperatura: EVITAR FEBRE; manter normotermia (36-37,5 C); hipotermia terapêutica em casos selecionados

Metabólico: corrigir hipoglicemia e distúrbios eletrolíticos

Neuro: tratar convulsões; monitorização contínua

PROGNÓSTICO E PREVENÇÃO

PONTOS-CHAVE

- Prognóstico reservado (sobrevida com bom desfecho neurológico baixa, sobretudo extra-hospitalar)
- Bom prognóstico: PCR testemunhada, RCP precoce de alta qualidade, ritmo chocável inicial
- A MELHOR estratégia é PREVENIR a PCR (reconhecer/tratar insuficiência respiratória e choque)
- RCP de alta qualidade (frequência/profundidade/retorno/mínimas interrupções) é o que mais impacta
- Adrenalina precoce em ritmos não chocáveis; desfibrilação imediata nos chocáveis

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PÓS-RCE

- Criança ____ anos/____ kg, PCR ____ (presenciada?), ritmo inicial ____ (chocável/não chocável); causa provável: ____.
- RCP ____ min; adrenalina ____ doses; desfibrilação ____; RCE às ____.
- Pós-RCE: via aérea ____, SatO2 ____, PA ____, glicemia ____, temperatura ____.
- Solicito UTI pediátrica + transferência; causa reversível tratada: ____ (Hs e Ts).



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é a causa MAIS comum de parada cardiorrespiratória na criança?

- A) Arritmia cardíaca primária
- B) Hipóxia/insuficiência respiratória (e choque)
- C) Infarto do miocárdio
- D) Embolia pulmonar
- E) Tamponamento cardíaco

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual a dose de adrenalina na PCR pediátrica e a frequência de repetição?

- A) 0,1 mg/kg a cada 10 min
- B) 0,01 mg/kg (0,1 mL/kg de 1:10.000) IV/IO a cada 3-5 min
- C) 1 mg fixo a cada 3 min
- D) 0,5 mg/kg dose única
- E) Não se usa adrenalina em crianças

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual a energia do primeiro choque na FV/TVSP pediátrica?

- A) 0,5 J/kg
- B) 2 J/kg (subsequentes 4 J/kg)
- C) 10 J/kg de início
- D) 200 J fixo
- E) Não se desfibrila crianças

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Em lactente, onde se palpa o pulso central durante a avaliação da PCR?

- A) Carotídeo
- B) Braquial
- C) Radial
- D) Pedioso
- E) Femoral exclusivamente

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual a relação compressão:ventilação na RCP pediátrica com DOIS socorristas (sem via aérea avançada)?

- A) 30:2
- B) 15:2
- C) 5:1
- D) 10:2
- E) Compressões contínuas sem ventilar

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Diferentemente do adulto (cardíaca/arrítmica), a PCR pediátrica é predominantemente HIPÓXICA (e por choque) — ~80% dos casos. Por isso o foco é reconhecer e tratar precocemente a insuficiência respiratória e o choque.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Adrenalina 0,01 mg/kg (0,1 mL/kg da solução 1:10.000) IV/IO, repetida a cada 3-5 min, em TODOS os ritmos de PCR pediátrica.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Na FV/TVSP pediátrica, o primeiro choque é 2 J/kg e os subsequentes 4 J/kg (podendo chegar a 10 J/kg ou à dose adulta). Ritmos chocáveis são raros na criança (<10%).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

No lactente (< 1 ano), palpa-se o pulso BRAQUIAL; na criança (> 1 ano), carotídeo ou femoral. A checagem deve durar no máximo 10 segundos.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Com dois socorristas e sem via aérea avançada, a relação é 15:2 na criança (30:2 com um socorrista). Com via aérea avançada, compressões contínuas + 1 ventilação a cada 2-3s.

SM24
Suporte ao Plantão Médico